SDD 36 Sujet n°1

Spécialité : Rhumatologie

Date : 15/10/2024
Auteur : Antonin PICAUD (DES médecine générale, EDN 2023/2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item 94 - Rachialgie Item 270 - Douleurs lombaires aiguës
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 72 - Douleur du rachis
Matériel nécessaire à la station	1 bureau et 2 chaises
Contexte de la station	Consultation de médecine générale, femme de 52 ans

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale, en stage au cabinet.
Vous recevez au cabinet Mme R, âgée de 52 ans, qui présente une douleur lombaire.
Elle n'a pas d'antécédent personnel ni familial notable, ne prend pas de traitement, fume depuis ses 21 ans, boit de l'alcool occasionnellement, ne consomme pas d'autre drogue et travaille en tant qu'institutrice.
Par ailleurs, la patiente se sent bien moralement, ne semble pas anormalement inquiète de sa lombalgie et est épanouie dans son travail.

Consignes :
Vous avez 8 minutes :

- Un interrogatoire en lien avec sa lombalgie
- Proposer une imagerie si nécessaire

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique
- Rédiger une ordonnance
- Proposer de prise en charge thérapeutique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Depuis quand (aigu ou chronique)	*1 pt*
2.	Apparition de la douleur (brutale ou progressive)	*1 pt*
3.	Recherche d'irradiation	*1 pt*
4.	La douleur est-elle impulsive à la toux ou à la défécation ?	*1 pt*
5.	La douleur réveille-t-elle en deuxième partie de nuit ?	*1 pt*
6.	Existe-t-il un dérouillage matinal significatif ?	*1 pt*
7.	La douleur est-elle augmentée ou diminuée par l'activité ou si la douleur est plus importante le soir ou le matin ?	*1 pt*
8.	Existe-t-il une faiblesse des membres inférieurs ?	*1 pt*
9.	La patiente présente-t-elle une incontinence urinaire ou fécale ?	*1 pt*
10.	La patiente a-t-elle perdu la sensibilité du périnée ?	*1 pt*
11.	La patiente a-t-elle eu de la fièvre ?	*1 pt*
12.	La patiente présente-t-elle une altération de l'état général (asthénie, anorexie et amaigrissement) ? *Les 3 sont nécessaires à demander*	*1 pt*
13.	Pas de prescription d'imagerie dans l'immédiat	*1 pt*

Communications et attitudes

1. **APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL	17 points

<u>Éléments de rétroaction</u> :

Dans le cadre d'une lombalgie aiguë, l'urgence est de rechercher des **drapeaux rouges** indiquant la réalisation d'une **imagerie**.
Dans notre cas aucun drapeau rouge n'est présent, nous étions donc dans le cas d'une **lombalgie commune** ne nécessitant pas d'examen complémentaire.

Il est également nécessaire dans un objectif de prise en charge à plus long terme d'identifier les drapeaux jaunes, bleus et noirs afin d'anticiper la chronicisation des douleurs.

La grille de notation et le temps d'une station étant limités, avec en plus la question de l'imagerie à la fin, l'énoncé nous orientait vers la recherche des drapeaux rouges. Prenez bien le temps de comprendre ce qui est attendu de vous avant de vous lancer dans les ECOS pour ne pas vous perdre et passer à côté des points à rechercher !

DRAPEAUX ROUGES

- Douleur de type non mécanique : douleur d'aggravation progressive, présente au repos et en particulier durant la nuit.
- Symptôme neurologique étendu (déficit dans le contrôle des sphincters vésicaux ou anaux, atteinte motrice au niveau des jambes, syndrome de la queue-de-cheval).
- Paresthésie au niveau du pubis (ou périnée).
- Traumatisme important (tel qu'une chute de hauteur).
- Perte de poids inexpliquée.
- Antécédent de cancer.
- Usage de drogue intraveineuse, ou usage prolongé de corticoïdes (par exemple thérapie de l'asthme).
- Déformation structurale importante de la colonne.
- Douleur thoracique (rachialgies dorsales).
- Âge d'apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans.
- Fièvre.
- Altération de l'état général.

DRAPEAUX JAUNES

Indicateurs psychosociaux d'un risque accru de passage à la chronicité

- Indicateurs d'un risque accru de passage à la chronicité et/ou d'incapacité prolongée.
- Problèmes émotionnels tels que la dépression, l'anxiété, le stress, une tendance à une humeur dépressive et le retrait des activités sociales
- Attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos, comme l'idée que la douleur représenterait un danger ou qu'elle pourrait entraîner un handicap grave, un comportement passif avec attentes de solutions placées dans des traitements plutôt que dans une implication personnelle active
- Comportements douloureux inappropriés, en particulier d'évitement ou de réduction de l'activité, liés à la peur.
- Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou environnement de travail jugé hostile) ou problèmes liés à l'indemnisation (rente, pension d'invalidité).

DRAPEAUX BLEUS

Facteurs de pronostic liés aux représentations perçues du travail et de l'environnement par le travailleur

- Charge physique élevée de travail.
- Forte demande au travail et faible contrôle sur le travail.
- Manque de capacité à modifier son travail.
- Manque de soutien social.
- Pression temporelle ressentie.
- Absence de satisfaction au travail.
- Stress au travail.
- Faible espoir de reprise du travail.
- Peur de la rechute.

DRAPEAUX NOIRS

Facteurs de pronostic liés à la politique de l'entreprise, au système de soins et d'assurance

- Politique de l'employeur empêchant la réintégration progressive ou le changement de poste.
- Insécurité financière.
- Critères du système de compensation.
- Incitatifs financiers.
- Manque de contact avec le milieu de travail.
- Durée de l'arrêt maladie.

D'après la Société française de médecine du travail (SFMT). Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations de charges. Recommandations de bonne pratique. Rouen: SFMT; 2013.

fm_lombalgie_v2_2.pdf (has-sante.fr)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Mme R, âgée de 52 ans présente une douleur lombaire.
Elle n'a pas d'antécédent personnel ni familial notable, ne prend pas de traitement, fume depuis ses 21 ans, boit de l'alcool occasionnellement, ne consomme pas d'autre drogue et travaille en tant qu'institutrice.
Par ailleurs, la patiente se sent bien moralement, ne semble pas anormalement inquiète de sa lombalgie et est épanouie dans son travail.

Plan de la station ECOS :

La patiente est assise sur une chaise en face du médecin, de l'autre côté du bureau

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3)</u> :

Bonjour docteur, je viens vous voir pour une douleur au dos.

Identité du patient :

Mme R, 52 ans, 1m71, 55 kg

Mode de vie :

Institutrice, fait du yoga et lit beaucoup.
Est mariée, a 2 enfants (accouchements voie basse) dont un encore présent à la maison.
Ne fume pas, boit de l'alcool occasionnellement, ne consomme pas d'autre drogue.
Pas d'allergie connue.

Comportement global :

Patiente calme, pas d'inquiétude particulière, souhaite seulement être soulagée.

Antécédents personnels :

Asthme dans l'enfance.

Antécédents familiaux :

AVC chez son père à 72 ans.

Médicaments :

Pas de traitement de fond.
A pris uniquement un Doliprane pour son mal de dos, faisant passer la douleur de 5 ou 6/10 à 4/10 uniquement.

Symptômes positifs :

Si l'étudiant pose une question en lien avec les antécédents ou le mode de vie → "Rien de nouveau depuis la dernière fois"

Si l'étudiant demande depuis quand la patiente a mal → "Depuis hier"

Si l'étudiant demande le type de douleur → "C'est difficile à dire, je ne sais pas trop"

Si l'étudiant demande de coter la douleur → "Je dirais 5/10 là"

Si l'étudiant demande si la patiente a pris des médicaments pour la douleur → J'ai pris un Doliprane ce matin comme la douleur ne passait pas"

Si l'étudiant demande si l'antalgique a fait effet → "très légèrement, disons de 5 ou 6/10 à 4/10"

Si l'étudiant demande comment est apparue la douleur → "En soulevant un carton de feuilles en classe"

Si l'étudiant demande si la douleur irradie → "La douleur est située uniquement en bas du dos, en barre"

Si l'étudiant demande si la douleur est impulsive à la toux ou à la selle → "Oui la douleur augmente quand je tousse et quand je pousse"

Si l'étudiant demande si la douleur réveille en deuxième partie de nuit → "Non pas spécialement, ça m'a gêné toute la nuit"

Si l'étudiant demande si la douleur la nuit est spontanée ou aux changements de position → "Je dirais aux changements de position"

Si l'étudiant demande si la patiente met du temps de matin à se dérouiller le matin → "5-10 minutes"

Si l'étudiant demande si la douleur est augmentée ou diminuée au cours de l'activité → "La douleur augmente quand je bouge"

Si l'étudiant demande si la patiente a remarqué une faiblesse des membres inférieurs → "Non je n'ai pas perdu de force"

Si l'étudiant demande si la patiente a remarqué une incontinence urinaire ou fécale → "Non"

Si l'étudiant demande si la patiente a perdu la sensibilité du périnée ou si elle sent le passage de l'urine et des selles → "Comme d'habitude"

Si l'étudiant demande si la patiente a eu de la fièvre → "Non je n'ai pas remarqué"

Si l'étudiant demande si la patiente a perdu l'appétit → "Non du tout"

Si l'étudiant demande si la patiente a perdu du poids involontairement → "Mon poids est stable"

Si l'étudiant demande si la patiente est plus fatiguée que d'habitude → "Aujourd'hui oui à cause de la douleur et de ma mauvaise nuit mais c'est tout"

Si l'étudiant demande s'il y a eu des prises de drogue intra-veineuse → "Non je ne consomme pas de drogue"

Si l'étudiant demande si l'impact socio-professionnel :
" je ne suis pas allée travailler aujourd'hui mais pas besoin d'un arrêt de travail"

Constantes :

TA : 131/79 mmHg
FC : 76 bpm
T° : 37,2 °C

Questions de relance :

Lorsqu’il reste 30 secondes, demander à l’étudiant s’il y aura besoin de réaliser une imagerie.